

Un adulte autiste dans votre cabinet

Pour les médecins de famille et les professionnels de santé — soigner un adulte actif.

L'idée centrale

L'autisme, vu sous l'angle du **monotropisme**, signifie que l'attention d'un adulte se verrouille dans quelques « tunnels » profonds et intenses. Dans le bon environnement, cela procure des forces réelles — concentration soutenue, fiabilité, détection de motifs, profondeur et honnêteté. Dans le mauvais (bureaux en open-space, interruptions constantes, attentes floues, politique de bureau), cela entraîne un épuisement chronique, du camouflage et un **burnout autistique**. Beaucoup d'adultes autistes actifs — particulièrement les femmes — n'ont été diagnostiqués qu'à l'âge adulte. Un rendez-vous de 15 minutes montre rarement le coût réel.

Ce que vous pouvez observer — et ce qui se passe réellement

Vous observez...	Ce qui se passe souvent
Épuisé, ne peut pas récupérer après le travail, perd des compétences	Burnout autistique — distinct du burnout professionnel classique et de la dépression
Anxiété, humeur basse, troubles du sommeil ou problèmes GI	Comorbidités courantes et signaux de surcharge
« Tout va bien » en consultation, s'effondre pendant des jours après	Camouflage intensif ; le coût réel est payé hors vue
Ne signale pas la douleur, les symptômes ou les effets secondaires avant qu'ils ne soient sévères	Différences d' intéroception — les signaux internes peuvent ne pas être enregistrés lorsqu'on est absorbé
Préfère les emails aux appels ; a besoin d'écrits	Communication sur un canal unique, réduit la charge

Essayez ceci

- **Proposez l'outil AASPIRE AHAT** avant la visite et des options **priorité à l'écrit** ; autorisez la présence d'un accompagnateur.
- **Reconnaissez le burnout autistique** — épuisement chronique, perte de fonction, tolérance réduite aux stimuli — et ne le confondez pas avec la dépression ou la paresse.
- **Interrogez sur la charge au travail et la récupération** : open-space, réunions, interruptions, camouflage.
- **Commencez les médicaments à faible dose et titration lente** — les adultes autistes rapportent souvent des réponses sensorielles/émotionnelles atypiques.
- **Orientez vers les aménagements du poste de travail** (Loi sur l'égalité / ADA) et suggérez que la personne est l'experte de ce qui l'aide.

Évitez ceci

- Traiter le burnout comme une dépression et pousser le patient à « faire plus d'efforts » ou à camoufler davantage — cela aggrave la situation et augmente le risque suicidaire.
- Laisser un calme masqué de 15 minutes occulter le récit et l'histoire du patient.

- Supposer que « ne pas se plaindre » signifie « ne pas souffrir ».

Quand demander plus de soutien

Évaluez la **suicidalité** — le burnout y est lié. Traitez les comorbidités (**TDAH/AuDHD, anxiété, dépression, sommeil et troubles GI**). Lorsque le burnout est sévère, validez un **temps d'arrêt ou une réduction des attentes** comme étape de récupération, et non comme une faiblesse. Documentez les aménagements efficaces pour qu'ils deviennent automatiques.

Si le patient est une femme

Les femmes sont surreprésentées parmi la « génération perdue » des adultes diagnostiqués tardivement et camouflent le plus intensément. Prenez au sérieux un schéma de différence sensorielle/sociale et d'épuisement privé, même avec une apparence « réussie ».

À propos de ce guide

*Assisté par IA, dérivé des brouillons de recherche du projet — le brief **Monotropisme** et le **Guide pour les praticiens et professionnels de santé** (Parties 3.4 & 4). Utilisez le langage identitaire. **Informatif — ce n'est pas un avis médical ni un outil de diagnostic**. Adaptez-le à l'individu.*

Sources clés. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Mantzalas et al. (2022, facteurs protecteurs du burnout); Pearson & Rose (2021, masking); Knight (2021); Kelly Mahler (2024, interoception); AASPIRE AHAT. Les citations complètes se trouvent dans les brouillons sources.